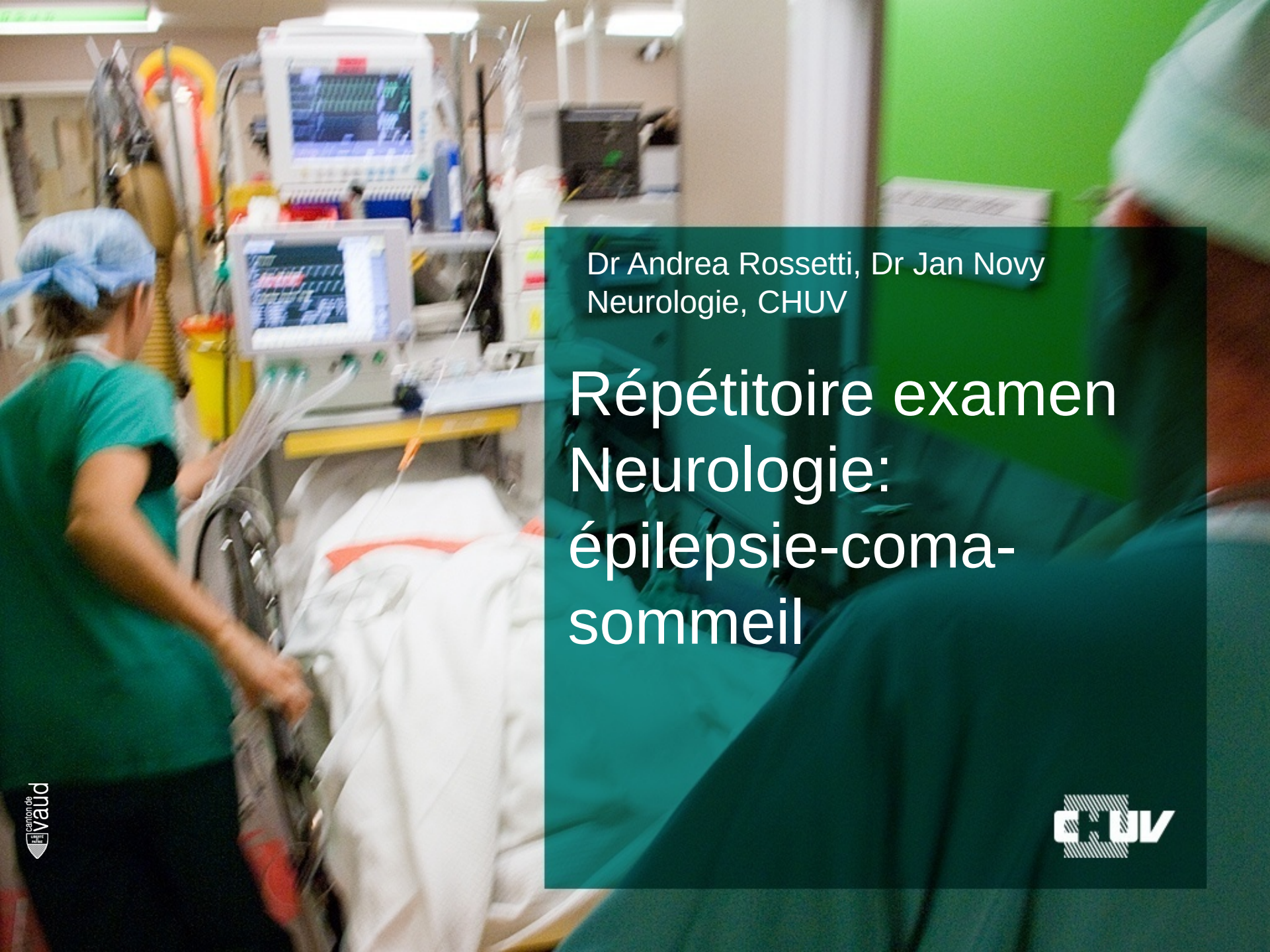


The background image shows a hospital room. On the left, a nurse in green scrubs and a blue hairnet is attending to a patient in a bed. The patient is covered with a white sheet. In the background, there are medical monitors displaying vital signs, various tubes, and medical equipment. The room has a green wall on the right side.

Dr Andrea Rossetti, Dr Jan Novy
Neurologie, CHUV

Répétitoire examen Neurologie: épilepsie-coma- sommeil

Question 1

- Un patient fumeur de 65 ans est emmené en ambulance aux Urgences après avoir été retrouvé inanimé à son domicile. Il respire irrégulièrement, le teint est grisâtre, il n'y a pas de mouvements spontanés, mais à la douleur il ébauche une défense non ciblée ddc. Les yeux sont fermés, et les réflexes du tronc cérébral sont préservés ddc. Laquelle des entités suivantes est la moins probable ?
 - a. Un accident vasculaire cérébral ischémique
 - b. Un état post-critique après une crise épileptique convulsive
 - c. Une intoxication médicamenteuse
 - d. Un état post-critique après un TCC
 - e. Une hypoxie et hypercapnie prolongées sur BPCO

Question 1

- Un patient fumeur de 65 ans est emmené en ambulance aux Urgences après avoir été retrouvé inanimé à son domicile. Il respire irrégulièrement, le teint est grisâtre, il n'y a pas de mouvements spontanés, mais à la douleur il ébauche une défense non ciblée ddc. Les yeux sont fermés, et les réflexes du tronc cérébral sont préservés ddc. Laquelle des entités suivantes est la moins probable ?
 - a. Un accident vasculaire cérébral ischémique
 - b. Un état post-critique après une crise épileptique convulsive
 - c. Une intoxication médicamenteuse
 - d. Un état post-critique après un TCC
 - e. Une hypoxie et hypercapnie prolongées sur BPCO

Un AVC induit de manière exceptionnelle un atteinte isolé de la conscience, surtout sans anomalies de l'examen clinique du tronc cérébral. Un atteinte cérébrale diffuse est largement le plus probable ici

Question 2

- Une dame d'une quarantaine d'années est évaluée par le SMUR : elle est vue convulser par des passants. A votre arrivée sur place, 10 min plus tard, elle convulse toujours, avec des mouvements non-synchrones d'intensité fluctuante, et une rotation cyclique de la tête ; les yeux sont fermés, il y a une résistance à l'ouverture ; la respiration est bruyante, le teint est rougeâtre. Quelle est votre première démarche :
 - a. Administration de 10 mg de midazolam IM
 - b. Intubation après induction au propofol (2mg/kg en bolus)
 - c. Transport à l'hôpital en surveillant les paramètres vitaux
 - d. Réanimation CP complète

Question 2

- Une dame d'une quarantaine d'années est évaluée par le SMUR : elle est vue convulser par des passants. A votre arrivée sur place, 10 min plus tard, elle convulse toujours, avec des mouvements non-synchrones d'intensité fluctuante, et une rotation cyclique de la tête ; les yeux sont fermés, il y a une résistance à l'ouverture ; la respiration est bruyante, le teint est rougeâtre. Quelle est votre première démarche :
 - a. Administration de 10 mg de midazolam IM
 - b. Intubation après induction au propofol (2mg/kg en bolus)
 - c. Transport à l'hôpital en surveillant les paramètres vitaux**
 - d. Réanimation CP complète

Ici, la clinique est évocatrice de crises non-épileptiques psychogènes, donc pas de traitement pré-hospitalier

Question 3

- Un garçon de 4 ans inquiète sa mère car il présente des épisodes nocturnes répétés, survenant vers 23h00. La fréquence est de 1-2 épisodes/semaine, surtout lors de stress. Des fois, il déambule dans l'appartement sans contact verbal ou visuel. Le père aurait eu un somnambulisme à l'adolescence. Après un examen clinique normal, votre attitude est de :
 - a. Organiser une consultation du sommeil et polysomnographie
 - b. Organiser un EEG après déprivation de sommeil
 - c. Prescrire de la carbamazépine adaptée au poids
 - d. Rassurer la mère et suggérer de réveiller l'enfant vers 22h30
 - e. Organiser une évaluation psychiatrique de la famille

Question 3

- Un garçon de 4 ans inquiète sa mère car il présente des épisodes nocturnes répétés, survenant vers 23h00. La fréquence est de 1-2 épisodes/semaine, surtout lors de stress. Des fois, il déambule dans l'appartement sans contact verbal ou visuel. Le père aurait eu un somnambulisme à l'adolescence. Après un examen clinique normal, votre attitude est de :
 - a. Organiser une consultation du sommeil et polysomnographie
 - b. Organiser un EEG après déprivation de sommeil
 - c. Prescrire de la carbamazépine adaptée au poids
 - d. Rassurer la mère et suggérer de réveiller l'enfant vers 22h30**
 - e. Organiser une évaluation psychiatrique de la famille

La clinique avec l'anamnèse familiale sont évocateurs d'une parasomnie non-REM (dont fait partie le somnambulisme)

Question 4

- Une femme de 23 ans vous consulte car depuis 1 an elle s'endort au travail pendant 5-10 min. 1-3 fois/jour, et n'arrive pas à parler quand elle rit avec les copines. Une fois, elle n'arrivait pas à bouger les membres au réveil, tout en voyant un animal se diriger contre elle. Quelle est la phrase la plus appropriée pour décrire vos réflexions :
 - a. Un syndrome des apnées-hypopnées de sommeil doit être exclu en première hypothèse.
 - b. Un état dépressif larvé nécessite d'une approche spécialiste
 - c. Un EEG avec examen neuropsychologique est nécessaire pour confirmer le diagnostic
 - d. Un conseil génétique doit être organisé au plus vite
 - e. Une polysomnographie avec test répété d'endormissement est nécessaire pour confirmer le diagnostic

Question 4

- Une femme de 23 ans vous consulte car depuis 1 an elle s'endort au travail pendant 5-10 min. 1-3 fois/jour, et n'arrive pas à parler quand elle rit avec les copines. Une fois, elle n'arrivait pas à bouger les membres au réveil, tout en voyant un animal se diriger contre elle. Quelle est la phrase la plus appropriée pour décrire vos réflexions :
 - a. Un syndrome des apnées-hypopnées de sommeil doit être exclu en première hypothèse.
 - b. Un état dépressif larvé nécessite d'une approche spécialiste
 - c. Un EEG avec examen neuropsychologique est nécessaire pour confirmer le diagnostic
 - d. Un conseil génétique doit être organisé au plus vite
 - e. Une polysomnographie avec test répété d'endormissement est nécessaire pour confirmer le diagnostic**

La clinique est très suggestive d'une narcolépsie et un bilan du sommeil pour démontré des endormissement précoce en sommeil REM sont indiqué pour confirmer le diagnostic

Question 5

- Un employé de commerce de 55 ans, connu pour une tumeur cérébrale primaire (OMS grade III), présente une première convulsion épileptique. Il retrouve son état de base après 2h, l'EEG montre un ralentissement non irritatif en égard de la lésion connue, le CT cérébral injecté est inchangé (comparatif de 3 mois). Il n'y a pas de facteur favorisant. Vous :
 - a. Prescrivez un arrêt de travail (2 sem.) et revoyez le patient
 - b. Changez la chimiothérapie en accord avec les oncologues
 - c. Prescrivez du clonazépam pendant un mois
 - d. Prescrivez du lévétiracétam à long terme
 - e. Prescrivez de la phénytoïne à long terme

Question 5

- Un employé de commerce de 55 ans, connu pour une tumeur cérébrale primaire (OMS grade III), présente une première convulsion épileptique. Il retrouve son état de base après 2h, l'EEG montre un ralentissement non irritatif en égard de la lésion connue, le CT cérébral injecté est inchangé (comparatif de 3 mois). Il n'y a pas de facteur favorisant. Vous :
 - a. Prescrivez un arrêt de travail (2 sem.) et revoyez le patient
 - b. Changez la chimiothérapie en accord avec les oncologues
 - c. Prescrivez du clonazépam pendant un mois
 - d. Prescrivez du lévétiracétam à long terme**
 - e. Prescrivez de la phénytoïne à long terme

Une crise épileptique + lésion structurelle = épilepsie. Ici, il convient de prescrire un traitement sans interaction médicamenteuse, pour le pronostic oncologique

Question 6

- Une fille de 19 ans est victime d'une avalanche. Retrouvée après 4h, elle est réanimée avec succès au niveau cardiaque ; à l'arrivée au Soins Intensifs (T rectale 29.5°C) vous constatez l'absence complète des réflexes du tronc, elle est comateuse. Quelle est votre prochaine démarche :
 - a. Activer la filière pour donneurs d'organes, test d'apnée
 - b. Demander un EEG et un angio-CT cérébral
 - c. Re-évaluer la patiente 24-36h plus tard
 - d. Arrêter toute mesure de réanimation
 - e. Administrer IV de la vitamine B1 (thiamine, 300mg)

Question 6

- Une fille de 19 ans est victime d'une avalanche. Retrouvée après 4h, elle est réanimée avec succès au niveau cardiaque ; à l'arrivée au Soins Intensifs (T rectale 29.5°C) vous constatez l'absence complète des réflexes du tronc, elle est comateuse. Quelle est votre prochaine démarche :
 - a. Activer la filière pour donneurs d'organes, test d'apnée
 - b. Demander un EEG et un angio-CT cérébral
 - c. Re-évaluer la patiente 24-36h plus tard
 - d. Arrêter toute mesure de réanimation
 - e. Administrer IV de la vitamine B1 (thiamine, 300mg)

Clinique de mort cérébrale, mais ce diagnostic ne peut être posé qu'en normothermie